QCM — 40 questions

Coche une à trois réponses selon l’énoncé. Les corrigés argumentés sont regroupés après les questions.

THÈME • Fondements et intentions

Q01 Quels éléments caractérisent une démarche de bientraitance en soin ?

- [ ] A. Centrer le soin sur les besoins de la personne
- [ ] B. Satisfaire uniquement les habitudes du service
- [ ] C. Prendre en compte les proches lorsque c’est pertinent
- [ ] D. Assimiler la bientraitance à la seule politesse
- [ ] E. S’interroger sur les effets de ses décisions

Q02 La bientraitance consiste-t-elle uniquement à éviter les violences évidentes ?

- [ ] A. Oui, si aucun geste brutal n’est réalisé
- [ ] B. Non, elle demande aussi des actions positives d’accompagnement
- [ ] C. Oui, si les soins sont prescrits
- [ ] D. Oui, si le professionnel est rapide
- [ ] E. Non, elle inclut une réflexion sur le vécu de la personne

Q03 Quelle question correspond à une décision de soin pensée dans une démarche bientraitante ?

- [ ] A. Comment terminer le plus vite possible ?
- [ ] B. Quels bénéfices et risques cette décision comporte-t-elle pour la personne ?
- [ ] C. Comment éviter de consulter le patient ?
- [ ] D. Qui imposera le rythme du service ?
- [ ] E. Comment réduire toutes les interactions ?

Q04 Quels aspects du bien-être doivent être envisagés dans l’accompagnement ?

- [ ] A. Le vécu physique
- [ ] B. Uniquement les constantes mesurées
- [ ] C. Le vécu psychologique
- [ ] D. Uniquement le confort de l’équipe
- [ ] E. Les priorités exprimées par la personne

Q05 Une pratique est habituelle dans le service. Quelle attitude est la plus pertinente ?

- [ ] A. L’appliquer toujours sans se questionner
- [ ] B. L’évaluer selon les besoins et capacités de la personne
- [ ] C. Écarter la parole de la personne
- [ ] D. La considérer bientraitante du seul fait de son ancienneté
- [ ] E. Accepter de l’ajuster si elle gêne la personne

THÈME • Bénéfices, risques et contention

Q06 Lorsqu’une contention physique est évoquée pour un patient agité, quels éléments doivent être mis en discussion ?

- [ ] A. Le bénéfice attendu sur une situation à risque
- [ ] B. L’effet sur les mouvements et l’autonomie
- [ ] C. La suppression systématique de toute réévaluation
- [ ] D. L’effet possible sur la dignité et la confiance
- [ ] E. La seule tranquillité de l’équipe

Q07 Quel effet négatif d'une contention est évoqué pour la personne ?

- ☐ A. Une autonomie nécessairement accrue
- ☐ B. Une limitation des mouvements élémentaires
- ☐ C. Une communication automatiquement améliorée
- ☐ D. L'absence de toute atteinte à la dignité
- ☐ E. Une disparition de tous les risques

Q08 Une équipe pense qu'une mesure restrictive la rassurerait. Quelle analyse est correcte ?

- ☐ A. Le ressenti de l'équipe suffit à justifier la mesure
- ☐ B. La protection recherchée doit être confrontée aux risques pour le patient
- ☐ C. L'autonomie du patient reste un critère d'analyse
- ☐ D. Le risque relationnel n'a jamais d'importance
- ☐ E. Le bénéfice attendu ne doit pas être tenu pour acquis

Q09 Dans une réflexion bénéfices/risques, quelle information est pertinente ?

- ☐ A. L'effet possible sur la relation de confiance
- ☐ B. Uniquement le nombre de gestes effectués
- ☐ C. La préférence du professionnel sans autre élément
- ☐ D. L'impossibilité de réviser une décision
- ☐ E. Les capacités restant à la personne

Q10 Quel statut donner à l’exemple de contention étudié comme situation éthique ?

- [ ] A. Un protocole à appliquer à tout patient agité
- [ ] B. Une situation pour discuter des risques et bénéfices
- [ ] C. Une recommandation universelle de restriction
- [ ] D. Une façon de réfléchir à des conséquences contradictoires
- [ ] E. Une décision indépendante des besoins du patient

THÈME • Personne, singularité et vulnérabilité

Q11 Une personne soignée trouve essentiel de voir ses proches chaque semaine. Quelle attitude correspond à une approche centrée sur elle ?

- [ ] A. Considérer cela comme secondaire parce que non technique
- [ ] B. Intégrer cette priorité dans la compréhension de ses besoins
- [ ] C. Remplacer son avis par celui de l’équipe
- [ ] D. Présumer que tous les patients veulent la même chose
- [ ] E. Explorer comment préserver ce lien

Q12 Face à une personne ayant du mal à exprimer ses besoins, quelles attitudes sont adaptées ?

- [ ] A. Rechercher d’autres moyens de communication
- [ ] B. Supposer qu’elle n’a aucun choix
- [ ] C. Préserver ses capacités restantes
- [ ] D. L’exclure systématiquement des décisions
- [ ] E. Prendre le temps d’observer et de vérifier ses réactions

Q13 Que montre la vulnérabilité dans les situations analysées ?

- [ ] A. Un besoin d’attention particulière aux droits et à la considération
- [ ] B. Une incapacité absolue de toute personne concernée à choisir
- [ ] C. Un motif d’infantilisation
- [ ] D. Une raison d’ignorer l’entourage
- [ ] E. Une nécessité d’adapter l’accompagnement

Q14 Une personne en situation de handicap ne peut pas lire sans ses lunettes. Quelle démarche est cohérente ?

- [ ] A. Ignorer l’activité puisqu’elle n’est pas médicale
- [ ] B. Vérifier qu’elle dispose de ses lunettes
- [ ] C. Considérer les lunettes comme un outil favorisant l’activité et la communication
- [ ] D. Parler uniquement à l’accompagnant
- [ ] E. Laisser systématiquement les objets utiles hors de portée

Q15 Une personne vulnérable exprime difficilement son accord. Quelles affirmations sont prudentes ?

- [ ] A. Ne pas confondre difficulté d’expression et absence de préférence
- [ ] B. Éviter toute explication puisqu’elle ne répond pas vite
- [ ] C. Rechercher ses signes de compréhension et de confort
- [ ] D. Déduire son consentement du seul silence
- [ ] E. Adapter l’information et le temps laissé à la réponse

THÈME • Respect, dignité et autonomie

Q16 Quels principes la séance présente-t-elle comme centraux pour la bientraitance ?

- [ ] A. La dignité de la personne
- [ ] B. L’intimité
- [ ] C. Le respect de l’autonomie
- [ ] D. La priorité automatique du planning
- [ ] E. L’exclusion des proches

Q17 Préserver l’autonomie pendant une toilette signifie notamment :

- [ ] A. Laisser faire à la personne ce qu’elle peut réaliser
- [ ] B. Tout faire à sa place pour aller vite
- [ ] C. Lui demander comment elle souhaite être aidée
- [ ] D. Supprimer toute explication
- [ ] E. Adapter l’aide à ses capacités

Q18 Quelle situation relève d’une atteinte possible à la sécurité morale ?

- [ ] A. Une personne tenue à l’écart de toute conversation la concernant
- [ ] B. Une explication adaptée à la compréhension
- [ ] C. Un temps de réponse respecté
- [ ] D. Une participation aux choix
- [ ] E. Une activité préférée proposée

Q19 Quels comportements favorisent le respect de la dignité ?

- [ ] A. Reconnaître la personne au-delà de son handicap
- [ ] B. Employer une appellation respectueuse
- [ ] C. Lui parler comme à un objet de soin
- [ ] D. La mettre à l'écart quand elle ne parle pas
- [ ] E. S'adresser à elle plutôt qu'uniquement à ses proches

Q20 Une personne peut être à l'abri d'une chute tout en se sentant humiliée. Quelle conclusion est correcte ?

- [ ] A. Seule la sécurité physique détermine la qualité du soin
- [ ] B. L'évaluation doit aussi considérer son vécu moral
- [ ] C. La dignité peut être affectée malgré une protection physique
- [ ] D. L'humiliation est toujours sans conséquence
- [ ] E. La sécurité physique et la sécurité morale sont complémentaires

THÈME • Communication, intimité et consentement

Q21 Avant une aide à la toilette, quelles attitudes sont adaptées ?

- [ ] A. Se présenter
- [ ] B. Expliquer ce qui est proposé
- [ ] C. Entrer systématiquement sans frapper
- [ ] D. Rechercher l'accord de la personne
- [ ] E. Imposer un geste sans information

Q22 Quel problème pose le fait d'appeler systématiquement une personne âgée « mamie » ?

- [ ] A. Cela peut être infantilisant
- [ ] B. C'est toujours son appellation préférée
- [ ] C. Cela peut manquer de respect à son identité
- [ ] D. Cela garantit une relation de confiance
- [ ] E. Cela dispense de connaître son nom

Q23 Un professionnel répond à la place d'un patient qui peut s'exprimer. Quelles critiques sont pertinentes ?

- [ ] A. La parole du patient est court-circuitée
- [ ] B. Cela peut réduire sa participation
- [ ] C. Cela garantit toujours un recueil fiable
- [ ] D. Cela préserve systématiquement l'autonomie
- [ ] E. Il faut lui laisser la possibilité de répondre

Q24 Quels éléments relèvent du respect de l'intimité ?

- [ ] A. Couvrir le corps lorsque c'est nécessaire
- [ ] B. Tenir compte de la pudeur
- [ ] C. Laisser les affaires personnelles exposées sans nécessité
- [ ] D. Éviter une exposition corporelle injustifiée
- [ ] E. Ignorer la température de la pièce

Q25 Une personne âgée demande à être rapprochée d'un être aimé. Quelle posture est adaptée ?

- [ ] A. Juger la demande à partir de son âge
- [ ] B. Écouter la demande et la considérer avec respect
- [ ] C. Reconnaître la vie affective de la personne
- [ ] D. Répondre par la moquerie
- [ ] E. Rechercher ce qui est possible dans la situation

THÈME • Soins techniques et prendre soin

Q26 Un geste technique réussi suffit-il à lui seul pour garantir une prise en soin adaptée ?

- [ ] A. Oui, dès lors que le geste est rapide
- [ ] B. Non, la relation et les besoins sont aussi importants
- [ ] C. Oui, si le patient ne pose pas de question
- [ ] D. Non, la réaction du patient doit être prise en compte
- [ ] E. Oui, si l'équipe est expérimentée

Q27 Pendant un prélèvement, le patient indique qu'il ne va pas bien moralement. Quelle attitude est appropriée ?

- [ ] A. Ignorer l'information pour finir plus vite
- [ ] B. Accueillir sa parole
- [ ] C. Explorer, dans le cadre du soin, ce qu'il souhaite exprimer
- [ ] D. Affirmer sans écouter qu'il ne se passe rien
- [ ] E. Maintenir une attention relationnelle pendant le geste

Q28 Une soignante dépose un plateau-repas et repart immédiatement. Quelle question est prioritaire ?

- ☐ A. La personne peut-elle et souhaite-t-elle manger avec l’aide proposée ?
- ☐ B. Le plateau a-t-il quitté le chariot ?
- ☐ C. Le service est-il terminé pour l’équipe ?
- ☐ D. La personne pourra-t-elle se débrouiller, quoi qu’il arrive ?
- ☐ E. Peut-on éviter tout échange ?

Q29 Quelles actions peuvent relever du prendre soin sans geste technique ?

- ☐ A. Écouter une inquiétude
- ☐ B. Expliquer une situation
- ☐ C. Accompagner une activité adaptée
- ☐ D. Ignorer une demande affective
- ☐ E. Écarter la personne de toute décision

Q30 Le professionnel hésite entre faire rapidement à la place du patient ou le laisser agir avec aide. Quels critères comptent ?

- ☐ A. Les capacités restantes
- ☐ B. Le rythme et les souhaits du patient
- ☐ C. Le confort exclusif du professionnel
- ☐ D. L’effet sur l’autonomie
- ☐ E. Une routine fixée quelle que soit la situation

THÈME • Travail d’équipe et contexte institutionnel

Q31 La bientraitance concerne-t-elle uniquement la responsabilité individuelle du soignant ?

- ☐ A. Oui, l’organisation n’a aucune influence
- ☐ B. Non, elle comprend des actions individuelles et collectives
- ☐ C. Oui, les transmissions sont sans effet
- ☐ D. Non, l’organisation peut faciliter ou entraver les pratiques
- ☐ E. Oui, les projets de vie sont hors sujet

Q32 Quels moyens aident une équipe à mieux répondre aux besoins d’une personne ?

- ☐ A. Partager les observations pertinentes
- ☐ B. Utiliser les transmissions
- ☐ C. Écarter toute discussion sur le projet de vie
- ☐ D. Échanger sur les adaptations possibles
- ☐ E. Ignorer la parole des aides-soignants

Q33 Un horaire de tournée empêche souvent de respecter le rythme d’une personne. Quelle réaction est pertinente ?

- ☐ A. Considérer l’horaire comme forcément intangible
- ☐ B. Questionner l’organisation et rechercher une adaptation
- ☐ C. Rejeter automatiquement la faute sur un seul soignant
- ☐ D. Discuter en équipe de solutions réalistes
- ☐ E. Supprimer l’attention aux préférences de la personne

Q34 Une soignante est brusque dans un contexte de sous-effectif. Quelles analyses sont nuancées ?

- ☐ A. Les conditions de travail peuvent contribuer à comprendre la situation
- ☐ B. Les contraintes justifient automatiquement toute attitude
- ☐ C. La dignité du patient reste à préserver
- ☐ D. Une amélioration organisationnelle peut être recherchée
- ☐ E. La seule solution est de nier l'incident

Q35 Dans un lieu de vie pour personnes âgées, que peut apporter le projet de vie ?

- ☐ A. Des informations sur les activités et préférences
- ☐ B. Un programme identique imposé à tous
- ☐ C. Des repères pour adapter l'accompagnement
- ☐ D. La suppression des échanges avec la personne
- ☐ E. Une aide à la continuité entre professionnels

THÈME • Analyser et réajuster une situation

Q36 Lorsqu'une vidéo de soin montre une interaction difficile, quelle démarche méthodologique est pertinente ?

- ☐ A. Décrire les comportements observables
- ☐ B. Affirmer connaître avec certitude l'intention du soignant
- ☐ C. Évoquer prudemment un effet possible sur la personne
- ☐ D. Proposer un ajustement concret
- ☐ E. Réduire l'analyse à « c'est méchant »

Q37 Une soignante parle dos tourné à la personne pendant un soin. Quelle modification est adaptée ?

- ☐ A. Prendre le temps de se tourner vers elle lorsque possible
- ☐ B. Continuer sans chercher de contact
- ☐ C. Lui expliquer l’action et rechercher son attention
- ☐ D. L’empêcher de poser des questions
- ☐ E. Vérifier sa compréhension

Q38 Une personne paraît triste après une interaction. Quelles formulations respectent la distinction fait/interprétation ?

- ☐ A. « Elle paraît triste ; il faut lui demander ce qu’elle ressent. »
- ☐ B. « Le soignant voulait nécessairement la blesser. »
- ☐ C. « Nous avons observé qu’elle s’est tue après l’échange. »
- ☐ D. « Nous savons exactement ce qu’elle pense. »
- ☐ E. « Une vérification de son ressenti est nécessaire. »

Q39 Après un réajustement relationnel, quelle dernière étape reste nécessaire ?

- ☐ A. Vérifier si l’action convient à la personne
- ☐ B. Considérer l’intention comme une preuve de réussite
- ☐ C. Éviter toute question de suivi
- ☐ D. Revenir uniquement aux habitudes du service
- ☐ E. Supposer que le problème est définitivement résolu

Q40 Quelle synthèse décrit le mieux une posture bientraitante au quotidien ?

- ☐ A. Respecter la personne et ses droits
- ☐ B. Écouter ses besoins et préférences
- ☐ C. Faire disparaître sa participation pour gagner du temps
- ☐ D. Adapter l’aide à ses capacités
- ☐ E. Se limiter à la réussite technique du geste

Corrigés argumentés

Chaque correction correspond à la même question que dans la partie entraînement.

THÈME • Fondements et intentions

Q01 - Réponses : A, C, E

La bientraitance recherche une réponse adaptée aux besoins de la personne et de son entourage et demande de réfléchir aux effets des actes.

Q02 - Réponses : B, E

Ne pas maltraiter ne suffit pas : écouter, adapter, faire participer et considérer le vécu donnent un contenu positif à la bientraitance.

Q03 - Réponses : B

La réflexion bénéfices/risques ne porte pas seulement sur la sécurité immédiate : elle inclut aussi l’autonomie, la dignité et la confiance.

Q04 - Réponses : A, C, E

L’approche décrite dans la séance associe bien-être physique et psychologique et accorde une place essentielle à ce qui compte pour le patient.

Q05 - Réponses : B, E

Une habitude d’organisation ne garantit pas une pratique adaptée. La bientraitance demande de réexaminer la réponse proposée au regard du patient.

THÈME • Bénéfices, risques et contention

Q06 - Réponses : A, B, D

Le scénario pédagogique de la contention confronte le bénéfice attendu à des atteintes possibles à l’autonomie, à la dignité et à la relation de confiance.

Q07 - Réponses : B

Immobiliser une personne peut réduire ses possibilités d’action, y compris pour des gestes simples ; l’analyse doit intégrer cette conséquence.

Q08 - Réponses : B, C, E

La sécurité de l'équipe ou sa sérénité ne remplacent pas une évaluation centrée sur la personne, ses droits et les effets possibles de la décision.

Q09 - Réponses : A, E

Le lien de confiance et la préservation des capacités comptent dans l'analyse d'un soin, au même titre que ses effets physiques.

Q10 - Réponses : B, D

Le cas sert à faire raisonner les étudiants : il n'autorise pas une conduite clinique standardisée pour les patients agités.

THÈME • Personne, singularité et vulnérabilité

Q11 - Réponses : B, E

La séance souligne que ce qui paraît simple au soignant peut avoir une grande valeur pour la personne et son bien-être.

Q12 - Réponses : A, C, E

Une difficulté à communiquer accroît la vigilance nécessaire mais ne supprime ni la dignité ni la recherche des choix et capacités.

Q13 - Réponses : A, E

La vulnérabilité appelle une protection respectueuse et une adaptation du soin, sans assimiler systématiquement la personne à une incapacité totale.

Q14 - Réponses : B, C

Le commentaire oral sur la vidéo met en relation les lunettes, la possibilité de lire et la participation à la vie quotidienne.

Q15 - Réponses : A, C, E

L'absence de réponse immédiate ne dispense pas de rechercher une participation adaptée ; la réflexion porte sur le respect des droits et le vécu.

THÈME • Respect, dignité et autonomie

Q16 - Réponses : A, B, C

La séance insiste sur la dignité, l'intimité, l'autonomie ainsi que le respect de la personne, de l'entourage et de la sécurité.

Q17 - Réponses : A, C, E

La préservation de l'autonomie suppose de rechercher les capacités restantes et de limiter la substitution inutile.

Q18 - Réponses : A

L'isolement et la non-reconnaissance de la personne peuvent nuire à son sentiment d'exister et à son bien-être moral.

Q19 - Réponses : A, B, E

La dignité se traduit par des gestes et paroles qui reconnaissent la personne comme sujet, même en situation de dépendance.

Q20 - Réponses : B, C, E

Le soin peut protéger le corps et néanmoins compromettre la dignité ou le sentiment de considération : plusieurs dimensions sont à analyser.

THÈME • Communication, intimité et consentement

Q21 - Réponses : A, B, D

Frapper, se présenter, informer et rechercher le consentement donnent à la personne la place d'actrice de son soin.

Q22 - Réponses : A, C

Un surnom familial imposé peut réduire une personne à son âge et ne tient pas compte de l'appellation qu'elle souhaite.

Q23 - Réponses : A, B, E

Répondre à la place de la personne la rend moins visible dans le soin et peut empêcher de connaître son expérience propre.

Q24 - Réponses : A, B, D

Le respect de l'intimité concerne le corps, la pudeur, le cadre du soin et les affaires personnelles.

Q25 - Réponses : B, C, E

La scène orale discute le droit au lien affectif et au contact, sans jugement lié à l'âge ou aux représentations du soignant.

THÈME • Soins techniques et prendre soin

Q26 - Réponses : B, D

Un soin ne se limite pas à exécuter un geste : le vécu de la personne et la communication comptent également.

Q27 - Réponses : B, C, E

Le soin technique est aussi une occasion de relation : une parole spontanée de la personne mérite une réponse attentive.

Q28 - Réponses : A

Distribuer le plateau ne remplace pas l'accompagnement du repas : autonomie, besoins d'aide et vécu doivent être vérifiés.

Q29 - Réponses : A, B, C

L'écoute, l'information, le lien et les activités adaptées ont une valeur relationnelle même sans acte technique.

Q30 - Réponses : A, B, D

Le temps nécessaire ne doit pas à lui seul effacer la participation possible de la personne et le respect de ses capacités.

THÈME • Travail d'équipe et contexte institutionnel

Q31 - Réponses : B, D

La séance rappelle l'importance du travail en équipe, des transmissions, des projets de vie et des conditions institutionnelles.

Q32 - Réponses : A, B, D

L'enseignante met en avant les transmissions, les échanges d'équipe et l'attention aux projets de vie, notamment en structure.

Q33 - Réponses : B, D

La contrainte d’organisation peut expliquer une difficulté mais n’empêche pas de chercher une réponse collective.

Q34 - Réponses : A, C, D

Comprendre les facteurs collectifs ne revient pas à excuser un comportement inadapté. Il faut protéger la personne et réfléchir aux conditions de travail.

Q35 - Réponses : A, C, E

Le projet de vie sert à connaître les préférences et à adapter l’accompagnement au-delà de la succession d’actes.

THÈME • Analyser et réajuster une situation

Q36 - Réponses : A, C, D

Le raisonnement doit distinguer les faits, les effets possibles et les ajustements observables, sans réduire la situation à un jugement.

Q37 - Réponses : A, C, E

Le regard, l’explication et la recherche de compréhension participent à la reconnaissance de la personne.

Q38 - Réponses : A, C, E

Observer une expression ou un silence ne permet pas d’affirmer un état interne ou une intention ; le ressenti doit être exploré.

Q39 - Réponses : A

L’évaluation de l’effet réel sur la personne fait partie du raisonnement : une bonne intention ne suffit pas.

Q40 - Réponses : A, B, D

Le soin bientraitant articule dignité, autonomie, communication et réévaluation des effets des actions.